ASL Murgia Adriatica
Presidio Territoriale San Nicola Pellegrino
Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche
Responsabile: Dott. Rocco Dimauro

Via Giulio Petroni 129
70124 Bari
Tel. 080 5843317

VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO

Follow-up diabete mellito tipo 2 e screening del piede diabetico

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**Lattarulo**	Nome:	**Vito Antonio**
Nato a:	**Bari il 18/06/1941**	C.F.:	**LTTVNT41H18A662O**
Residenza:	**Via Fanelli 214/B, Bari**	Esenzione:	**013.250**
Recapito:	**+39 340 778 2165 (figlio)**	MMG:	**Dott.ssa Annalisa Pepe**

Data visita:	4 marzo 2025	Pren. CUP:	BA250304-1187	NRE:	160A51199027744
Prestazione:	89.01 - Visita di controllo	Priorità:	P - programmata	Regime:	SSN, esente

Prenotazione: BA250304-1187

Il sig. Lattarulo, di 83 aa., giunge a controllo accompagnato dalla badante, sig.ra Oksana Kovalenko, che ne cura la gestione quotidiana della terapia insulinica, e dal figlio Nicola Lattarulo. Ultimo controllo presso il ns. ambulatorio il 12.09.24.

ANAMNESI

Diabete mellito tipo 2 noto dal 2003, in insulinoterapia basale dal 2019. Cardiopatia ischemica cronica, sottoposto a PTCA con stent su IVA nel 2015. Malattia renale cronica stadio 3b. Ipertensione arteriosa. Non retinopatia all'ultimo fundus (2024). Riferisce due episodi di ipoglicemia notturna nell'ultimo mese, riconosciuti e corretti dalla badante con zucchero per os. Vive con la badante; il figlio riferisce lieve deterioramento della memoria recente.

TERAPIA DOMICILIARE IN ATTO

Farmaco	Posologia	Note
Metformina 500 mg	1 cp a pranzo e a cena	dose ridotta per eGFR
Insulina glargine 100 UI/mL	14 UI alle ore 22	somministrata dalla badante
Acido acetilsalicilico 100 mg	1 cp a pranzo	-
Bisoprololo 2,5 mg	1 cp al mattino	-
Atorvastatina 40 mg	1 cp la sera	-

ESAMI EMATOCHIMICI E ANDAMENTO

Data prelievo	HbA1c (mmol/mol)	Glicemia a digiuno (mg/dL)	eGFR (mL/min)	Note
12.09.24	61	148	44	visita precedente
03-12-2024	58	131	41	lab. esterno convenzionato
20/02/2025	56	97	39	microalbuminuria 86 mg/g

ESAME OBIETTIVO

Condizioni generali discrete, deambulazione autonoma con bastone. PA 138/72 mmHg, FC 62 bpm ritmica. Peso 74,5 kg, altezza 168 cm, BMI 26,4. Glicemia capillare in ambulatorio 112 mg/dL (ore 10:30).

Screening del piede diabetico

Cute secca, ipercheratosi plantare alla testa del I metatarso dx, senza lesioni ulcerative. Polsi pedidi e tibiali posteriori iposfigmici bilateralmente. Test al monofilamento 10 g: sensibilità assente in 3 punti su 10 a dx e 2 punti su 10 a sx. Diapason 128 Hz ridotto al malleolo. Indice caviglia-braccio 0,82 dx e 0,88 sx.

CONCLUSIONI

Diabete mellito tipo 2 in insulinoterapia con compenso accettabile per età e comorbilità, gravato da ipoglicemie notturne. Neuropatia periferica sensitiva e arteriopatia obliterante periferica lieve: piede a rischio di classe 2. Nefropatia diabetica con progressiva riduzione del filtrato.
In considerazione dell'età del pz. e del rischio di ipoglicemia si accetta un target di HbA1c fino a 64 mmol/mol.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

- Ridurre insulina glargine a **12 UI** alle ore 22; non somministrare se glicemia serale inferiore a 120 mg/dL.
- Introdurre empagliflozin 10 mg 1 cp al mattino (nefroprotezione e protezione cardiovascolare); compilato piano terapeutico AIFA, consegnato al pz.
- Sospendere la metformina se eGFR inferiore a 30 mL/min.
- Visita podologica ed ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori.
- Controllo di creatinina, elettroliti ed esame urine tra 4 settimane.

Eseguita sessione educativa con l'infermiera Maria Grazia Lorusso sulla gestione delle ipoglicemie e sulla cura quotidiana del piede, rivolta alla sig.ra Kovalenko e al figlio, ai quali è stato consegnato il diario glicemico.
Prossimo controllo: 09/09/2025 ore 9:00, già prenotato (ambulatorio 3, primo piano).

Il Medico Diabetologo

Dott.ssa Gabriella Fanizzi
Visto il Responsabile del Servizio, Dott. Rocco Dimauro

Dott.ssa Gabriella Fanizzi
Specialista in Endocrinologia
e Malattie del Metabolismo

Bari, 04/03/2025